



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : لويزه سليمان منصور سليمان

العنوان : شبرا الخيمة ثان

الحي / المدينة : شبرا الخيمة

المحافظة : القليوبية

تاريخ تسجيل الإستمارة : 28-09-2026

رقم التليفون : 01205909573

رقم البطاقة : 25602062600947

العمر (تاريخ الميلاد) : 06-02-1956 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مسح ذري علي العظام [12966] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني الوظيفة: التوقيع:
الاسم: د/ندى حسن الوظيفة: التوقيع:
الاسم: د/نرمين رمضان الوظيفة: التوقيع:
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /..... /د. /..... /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: لويته سليمان منصور سليمان National ID: 25602062600947	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bone scintigraphy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

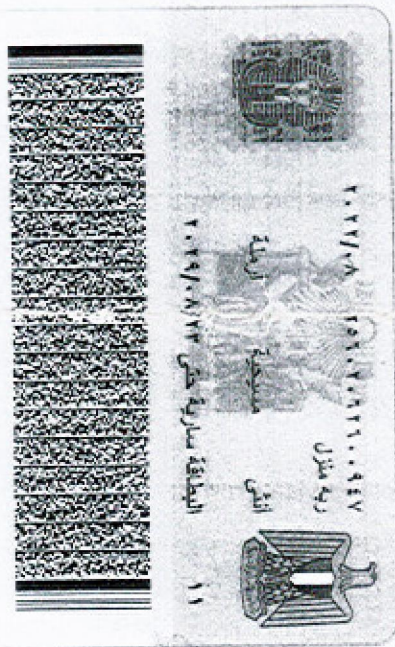
MS
مع ذري

جمهورية مصر العربية
بطاقة لمخاطب الشخصية



لويزه
سليمان منصور سليمان
ش ٢ - ارض الدكتور
شبرا الخيمة ثان - القليوبية

١٩٥٦/٠٢/٠١ ٢٥٦٠٢٠٦٢٦٠٠٩٤٧
JN4793238





رسوم الاستعلام 20 جنية

جهة الاصدار: فرع القليوبية

تاريخ الاصدار: 2026-7-9

التي من يهيمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانقاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس وقانون رقم 86 لسنة 2012 "الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة. وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي والبحث تبين أن

المسيد (ة) لويزه سليمان منصور بطاقة رقم 25602062600947

تليفون رقم: 01205909573

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية بليد عدم الانتفاع يعتبر من الفئات غير المنتفحة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل وشكرا

تاريخ الطباعة: 2026-7-9

الموظف المختص

سها م عبد النبي
ج.ج

إفادة مركز نظم المعلومات

بمقتضى

عبد النبي

مسلسل 2019033



الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغير حالة المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية للنظم المعلومات والتحول الرقمي

٤٩٠٧١ رقم إيداع

PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: لويزه سليمان منصور سليمان

Request type: مبادره

Hospital no:

Department: صحة مراد

Referred by: د/مروه حسن

Nature of specimen: tru-cut biopsy

Clinical diagnosis: Left breast mass

Age: 70.years

Sex: female

Sub request type:

Pathology no.: 620-2026

Date of result: 26/7/2026

Date of biopsy: 13/7/2026

I.D. Number: 25602062600947

Gross pathology:

multiple gray white cores up to 1cm long each, totally submitted

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: Ecadherine-ER- PR- Her2- Ki67.

Microscopic picture: Sections examined revealed breast tissue core showing malignant growth. Tumor forms files, single cells, sheets, clusters, cords and trabeculae infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showed moderate anaplasia with moderate tendency to form tubules and mitosis.

Immunohistochemical Result:

ER: Positive strong nuclear staining in 70% of tumor cells (Allred Score 8/8).

PR: Moderate nuclear staining of 70% of the tumor cells (7/8).

Her2: Moderate incomplete membranous staining of >10% of tumor cells (Score 1+) Her2 low

Ki67: Positive nuclear staining of 10% of tumor cells

Diagnosis: Left breast mass, tru-cut biopsy:

Provisional mammary core biopsy of, Mixed Invasive Ductal and lobular Carcinoma (NST), Grade II.

Signature:

Dr. Nermine Nabil.M.D

Dr. Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

Patient Name: [illegible]	Ref: [illegible]
Date: [illegible]	Time: [illegible]

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 70 years old female patient with long standing left lump with shrunken breast.

Detailed Findings

Left breast:

- Asymmetrical reduced size of the left breast shows an ill-circumscribed spiculated retroareolar dense mass lesion with internal microcalcifications, obscured margins and architectural distortion associated with nipple retraction.

Ultrasound revealed:

- A large ill-defined heterogeneous hypoechoic retroareolar mass lesion measures about 3.8 x 1.8 cm at its maximum diameters with nipple retraction.

- Another left axillary tail globular speculated hypoechoic mass lesion is seen measuring about 1.6 x 1.4 cm about 3.2 mm from the overlying skin.

- Few (about 2-3) enlarged axillary lymph nodes at level I with focal cortical thickening and indented hila, the largest one measures about 13 x 9.3 mm and 4.6 mm cortical thickening.

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).

- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.

- Ultrasound demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.

- No solid or cystic breast lesions.

- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.

- Right axillary lymph nodes with mild diffuse cortical thickening reaching up to 3.3 mm with reserved central fatty hila

Impression:

- Left breast (BIRADS 5): Left retroareolar and axillary tail malignant mass lesions with ipsilateral pathological axillary as described. For tru cut biopsy.

- Right breast (BIRADS 2): mild fibroadenosis.

*Much obliged,
Dr. Ayat Nadi, FEBR, ABR*